

AAMIA

Apoyo al Adulto Mayor con Inteligencia Artificial

Guía abierta para acompañar el cuidado cotidiano

Una referencia breve para familias y personas cuidadoras sobre observación inicial, alimentación, movimiento seguro, prevención de caídas y organización del cuidado.

Uso responsable

Este material es educativo. No diagnostica, no prescribe tratamientos y no sustituye al personal de salud. Adapta cualquier recomendación a la capacidad, preferencias e indicaciones clínicas de la persona.

Edición 1.0 · Julio de 2026

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Puedes copiar y adaptar esta guía si atribuyes al Proyecto AAMIA e indicas los cambios.

1. Cuidar comienza por conocer a la persona

No existe una única forma de envejecer. Un buen plan parte de lo que la persona puede y quiere hacer, de sus rutinas y de las barreras de su entorno. El objetivo es apoyar sin quitar autonomía. [1]

Antes de ayudar

Habla con calma y pide permiso. Explica cada paso antes de tocar, mover o cambiar la rutina.

- Pregunta cómo prefiere ser llamada y qué actividades desea realizar por sí misma.
- Identifica dificultades de visión, audición, movilidad, memoria, deglución o comunicación.
- Ten a mano contactos de familia, personal de salud y servicios de emergencia locales.
- Registra alergias, diagnósticos y medicamentos exactamente como fueron indicados; no ajustes dosis por cuenta propia.

Cambios que merecen atención

Compara con el estado habitual, no sólo con una lista genérica.

- Confusión nueva, somnolencia inusual, caída o debilidad repentina.
- Falta de aire, dolor fuerte o persistente, fiebre, vómitos repetidos o sangrado.
- Dificultad nueva para comer o beber, menos orina, boca muy seca o rechazo sostenido de alimentos.
- Cambios marcados en ánimo, conducta, sueño o capacidad para las tareas cotidianas.

Posible urgencia

Ante pérdida de conciencia, dificultad intensa para respirar, dolor torácico, sangrado que no cede o signos súbitos como rostro caído, debilidad de un brazo o habla alterada, contacta de inmediato a los servicios de emergencia locales. No esperes una respuesta de una aplicación.

2. Rutina de cuidados cotidianos

Una rutina predecible reduce olvidos y facilita detectar cambios. Debe ser flexible: la energía y las necesidades pueden variar cada día.

Al comenzar el día

Observa sin invadir y conversa sobre cómo se siente.

- Comprueba orientación, ánimo, dolor, respiración y capacidad para levantarse respecto del día anterior.
- Ofrece tiempo suficiente para aseo, vestido y baño; prepara los objetos en el orden de uso.
- Favorece ropa cómoda y calzado cerrado, firme y antideslizante.
- Revisa que lentes, auxiliares auditivos, bastón o andadera estén limpios, disponibles y en buen estado.

Durante el día

Combina actividad, descanso, alimentación y contacto social.

- Mantén agua y objetos de uso frecuente al alcance, según las restricciones indicadas por profesionales.
- Propón tareas con propósito: doblar ropa, regar plantas, conversar, escuchar música o caminar acompañado.
- Evita hacer por la persona lo que todavía puede realizar con tiempo o una adaptación sencilla.
- Revisa la piel expuesta a presión o humedad y solicita valoración si aparecen lesiones, dolor o enrojecimiento persistente.

Al cerrar el día

Un registro corto ayuda a comunicar hechos, no impresiones.

- Anota alimentación, líquidos, actividad, evacuaciones, sueño, caídas, dolor y cambios relevantes.
- Prepara iluminación nocturna y una ruta despejada hacia el baño.
- Comparte novedades con la red de apoyo y consulta cuando un cambio sea nuevo, empeore o preocupe.

3. Alimentación e hidratación

La OMS resume una alimentación saludable en cuatro principios: adecuación, equilibrio, moderación y diversidad. La composición exacta debe adaptarse a salud, cultura, disponibilidad, apetito y actividad. [2]

Una base práctica

Busca variedad y alimentos poco procesados, sin imponer un menú rígido.

- Incluye verduras y frutas, cereales integrales o tubérculos, leguminosas y fuentes de proteína apropiadas.
- Prefiere preparaciones sencillas y limita productos con exceso de sodio, azúcares libres y grasas no saludables. [2]
- Respeta preferencias y costumbres; comer acompañado puede mejorar la experiencia.
- Sirve porciones manejables y ofrece más si la persona lo desea.

Comer con seguridad

La tos, voz húmeda, atragantamiento o dificultad para masticar requieren valoración profesional.

- Procura una postura sentada y estable; evita alimentar a una persona somnolienta o acostada.
- Verifica temperatura, textura, dentadura y utensilios; no modifiques consistencias sin orientación si existe disfagia.
- Da tiempo para masticar y tragar. No apresures ni fuerces.
- Mantén higiene de manos, superficies, alimentos y boca.

Hidratación

Ofrece líquidos de forma regular si no existe una restricción médica.

- Usa un vaso fácil de sujetar y deja agua visible y accesible.
- Consulta ante rechazo persistente, orina muy escasa, mareo, debilidad o cambios agudos de atención.
- En enfermedad renal, cardíaca u otras condiciones, sigue la cantidad indicada por el equipo tratante.

4. Movimiento, fuerza y equilibrio

La actividad regular favorece capacidad física y mental. Para personas mayores, la OMS recomienda combinar actividad aeróbica, fortalecimiento y ejercicios multicomponente de equilibrio y fuerza. [3]

Meta de referencia, no receta

Cuando la salud y la capacidad lo permiten, la referencia poblacional es 150–300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada; además, fuerza al menos dos días y trabajo multicomponente tres o más días. [3]

- Si hoy hay poca actividad, empieza con periodos breves y aumenta de forma gradual.
- Caminar, bailar sentado o de pie, levantarse de una silla y tareas domésticas adaptadas también cuentan.
- Intercala descanso y evita comparar el ritmo con el de otras personas.
- Una persona con caída reciente, dolor, mareo o enfermedad descompensada necesita orientación antes de progresar.

Sesión sencilla y supervisada

Elige un espacio estable, iluminado y sin obstáculos.

- Inicio: movimientos suaves y respiración cómoda.
- Parte principal: una actividad que permita hablar, aunque con algo de esfuerzo; usa apoyo estable cuando haga falta.
- Final: reduce el ritmo de forma progresiva y observa cómo se siente.
- Suspende y pide ayuda si aparece dolor torácico, falta de aire intensa, desmayo, debilidad súbita o dolor agudo.

Dignidad y elección

El movimiento no debe usarse como castigo ni imponerse. Ofrece opciones, escucha el cansancio y celebra la constancia, no el rendimiento.

5. Hogar seguro y prevención de caídas

Las caídas pueden causar lesiones importantes. Revisar el entorno y practicar fuerza y equilibrio reduce riesgos, pero ninguna medida sustituye una valoración cuando ya hubo caídas o mareos. [4]

Recorrido de seguridad

Haz la revisión caminando por las rutas que la persona usa de día y de noche.

- Retira cables, tapetes sueltos, muebles bajos y objetos de zonas de paso.
- Mejora la iluminación, especialmente en escaleras, entradas y ruta al baño.
- Instala superficies antideslizantes y apoyos firmes donde sean necesarios; una toalla o mueble móvil no es un pasamanos.
- Deja teléfono, agua y artículos frecuentes a una altura accesible, sin necesidad de bancos o escaleras.
- Revisa que el calzado ajuste bien y que bastón o andadera tengan altura y mantenimiento adecuados.

Si ocurre una caída

Mantén la calma y pregunta por dolor. No levantes de inmediato a la persona si hay dolor intenso, golpe en la cabeza, deformidad, sangrado, pérdida de conciencia o incapacidad para moverse.

- Contacta a emergencias ante signos graves o si no puedes valorar la situación con seguridad.
- Aunque parezca estar bien, informa al equipo de salud si es una caída nueva o repetida.
- Registra qué ocurrió antes, dónde, calzado, iluminación, síntomas y posibles obstáculos.
- No atribuyas una caída simplemente a la edad: medicamentos, visión, presión arterial, infección o entorno pueden influir.

Baño

Es una zona de alto riesgo. Prioriza piso seco, tapete antideslizante, iluminación, barras correctamente fijadas y objetos al alcance. [4]

6. Medicamentos, memoria y bienestar

Medicamentos sin improvisar

La organización reduce errores, pero cualquier cambio corresponde al equipo tratante.

- Mantén una lista actualizada con nombre, dosis, horario, motivo y profesional que indicó cada producto.
- Incluye medicamentos sin receta, vitaminas, suplementos y productos herbolarios.
- Usa un único sistema de recordatorio y registra la toma; no dupliques una dosis olvidada sin indicación.
- No tritures tabletas ni abras cápsulas sin confirmar que sea seguro.
- Solicita revisión si aparecen mareos, somnolencia, confusión, caídas o dificultad para seguir el esquema.

Memoria y comunicación

Una rutina clara y un entorno amable suelen ayudar más que corregir repetidamente.

- Da una instrucción a la vez, deja tiempo para responder y reduce ruido de fondo.
- Usa calendarios, etiquetas sencillas y objetos siempre en el mismo lugar.
- Valida la emoción aunque el recuerdo sea impreciso; evita discutir para demostrar quién tiene razón.
- Consulta ante confusión repentina: un cambio agudo no debe asumirse como parte normal del envejecimiento.

La persona cuidadora también necesita cuidado

El cansancio sostenido afecta a ambas personas.

- Reparte tareas concretas y acuerda relevos antes de llegar al agotamiento.
- Conserva tiempo para dormir, comer, moverte y hablar con alguien de confianza.
- Busca apoyo profesional si hay desesperanza, irritabilidad persistente, aislamiento o sensación de no poder continuar.
- Pedir ayuda es una medida de seguridad, no un fracaso.

7. Plan breve y fuentes

Completa este plan con la persona adulta mayor y su red de apoyo.

Prioridad de esta semana	
Actividad que desea conservar	
Riesgo del hogar que corregiremos	
Persona a quien pediremos apoyo	
Cambio que consultaremos	

Fuentes de consulta

[1] Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento y salud (2025).

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

[2] Organización Mundial de la Salud. Alimentación saludable (2026).

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

[3] Organización Mundial de la Salud. Actividad física.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

[4] MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. Prevención de caídas.

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000052.htm>

[5] INAPAM. Manual de apoyo con el cuidado de personas adultas mayores (2024).

<https://www.gob.mx/inapam/documentos/122471>

Licencia abierta

© 2026 Proyecto AAMIA. Esta guía se ofrece bajo CC BY 4.0: creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es. Atribución sugerida: “Proyecto AAMIA, Guía abierta para acompañar el cuidado cotidiano, versión 1.0”.